

DLBCL / CNSL 新治疗与机制文 献监测

近 7 天官方 PubMed 窗口：2026-06-01 至 2026-06-07。每篇文章单独成页，按“标题、结论、主要内容、关键信息、启示”快速浏览；启示严格区分已验证证据、作者观点和我的推断。

EDAT 新入库	PDAT 发表日期	MDAT 记录更新	精选入页
42	69	213	5

固定公网主页：<https://zhengyipharmacy-collab.github.io/pubmed-lymphoma-slides/>

- 下载 PDF
- 下载 PPTX

检索与筛选说明

PubMed 官方 ESearch/EFetch 于 2026-06-07 检索；窗口为 2026-06-01 至 2026-06-07，合并 EDAT、PDAT、MDAT。按最新规则，本版只纳入 5 篇，并排除 pubmed-history.json 中 2026-06-03 至 2026-06-06 已覆盖的 PMID；若为 MDAT 命中或近期高相关参考，已在每篇状态中标注，不等同于近 7 天新发表。

检索式：((DLBCL[Title/Abstract] OR "diffuse large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR "large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR LBCL[Title/Abstract] OR PCNSL[Title/Abstract] OR "primary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "primary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR CNSL[Title/Abstract] OR "central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract]) AND lymphoma[Title/Abstract])

覆盖方向：BTKi、双抗、CAR-T/细胞治疗、ADC、免疫治疗、靶向联合、病例/病例系列、基础/机制/转化、耐药、CNS 穿透/药代、安全性和真实世界。

#	方向	疾病	PMID	标题	打开链接
1	BTKi 联合 / 一线真实世界	新诊断 DLBCL	41555062	BTK 抑制剂 + 利妥昔单抗 + 来那度胺一线治疗新诊断 DLBCL	打开文献
2	ADC / 随机 III 期临床试验	R/R DLBCL	39772655	ECHELON-3: BV + 来那度胺 + 利妥昔单抗治疗 R/R DLBCL	打开文献
3	双抗 / 长期随访临床研究	R/R LBCL	41634395	EPCORE NHL-1 三年更新: epcoritamab 治疗 R/R LBCL	打开文献
4	PCNSL / BTKi 联合前临床试验	新诊断 PCNSL	41582824	RLZT ± MTX 一线治疗 PCNSL: zanubrutinib 联合方案	打开文献
5	PCNSL / ASCT 巩固真实世界	PCNSL	42139822	PCNSL 中 BET 高剂量化疗 + ASCT 的长期真实世界疗效与安全性	打开文献

BTK 抑制剂 + 利妥昔单抗 + 来那度胺一线治疗新诊断 DLBCL

Efficacy of BTK inhibitor combined with rituximab and lenalidomide in newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma: a single-center, retrospective study.

PMID 41555062

打开 PubMed 文献

BTKi 联合 / 一线真实世界

新诊断 DLBCL

MDAT 近7天滚动候选：未在历史日报出现；近期高相关参考/补充



新诊断 DLBCL 患者，接受 SMART 类无化疗/低化疗强度联合方案



Orelabrutinib 或 zanubrutinib + rituximab + lenalidomide



OR2 vs ZR2 真实世界治疗队列及历史 Smart Start 背景



ORR、PFS、OS、3 级及以上 AE、中性粒细胞减少

结论

单中心真实世界研究提示，orelabrutinib 或 zanubrutinib 联合 rituximab/lenalidomide 的 SMART 类方案在新诊断 DLBCL 中显示较高缓解和可接受安全性，但仍属回顾性、非随机证据。

主要内容

- 回顾性纳入 2021-2024 年接受 rituximab、lenalidomide 加 BTK inhibitor 的新诊断 DLBCL 患者。
- 84 例用于疗效分析；OR2 方案 51 例，ZR2 方案 33 例。
- 中位随访 13.5 个月；中位 PFS 32.4 个月，1 年 PFS 85.3%，2 年 PFS 63.3%。
- 60.7% 患者发生 3 级及以上不良事件，最常见为中性粒细胞减少。

关键信息

- 这是未重复 PMID，符合 5 篇规则下的 BTKi/DLBCL 临床补充。
- 研究呼应 Smart Start 逻辑，但使用选择性更高的 zanubrutinib/orelabrutinib。
- 证据等级为单中心回顾性，不能替代随机研究。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认人群、SMART 类方案、OR2/ZR2 构成、PFS 和 3 级及以上 AE 信息。

论文作者观点

作者认为该真实世界数据支持 SMART regimen 作为 DLBCL 潜在治疗选择，疗效有希望且安全性可接受。

我的推断

我的推断是，BTKi 联合研究应固定记录 COO/non-GCB、年龄、骨髓储备和感染风险，避免只看早期 PFS。

ECHELON-3：BV + 来那度胺 + 利妥昔单抗治疗 R/R DLBCL

Brentuximab Vedotin Combination for Relapsed Diffuse Large B-Cell Lymphoma.

PMID 39772655

打开 PubMed 文献

ADC / 随机 III 期临床试验		R/R DLBCL		MDAT 近7天滚动候选：未在历史日报出现；近期高相关参考/补充	
P 复发/难治 DLBCL 患者		I Brentuximab vedotin + lenalidomide + rituximab		C Placebo + lenalidomide + rituximab	
				O OS、PFS、ORR、CR、TEAE	

结论

ECHELON-3 显示 BV + lenalidomide + rituximab 较 placebo + lenalidomide + rituximab 改善 OS、PFS 和 ORR，是 R/R DLBCL ADC 联合方向的重要随机证据。

主要内容

- 随机、双盲、安慰剂对照、多中心 III 期研究，纳入 230 例 R/R DLBCL。
- BV + Len + R 组中位 OS 13.8 个月，对照组 8.5 个月，HR 0.63，P=.009。
- 中位 PFS 4.2 vs 2.6 个月，HR 0.53，P<.001。
- ORR 64% vs 42%，CR 40% vs 19%；两组 TEAE 均为 97%。

关键信息

- 未重复 PMID；临床相关性高，且为 III 期随机研究。
- ADC 联合方向与 polatuzumab/loncastuximab 形成后线证据网络。
- 需要同时关注 OS 获益和血液学/胃肠道 AE 负担。

启示

已验证证据 PubMed 摘要确认研究设计、样本量、OS/PFS/ORR/CR 和主要安全性信息。	论文作者观点 作者认为 BV + Len + R 在重度经治 R/R DLBCL 中显示统计学显著生存获益且安全性可管理。	我的推断 我的推断是，R/R DLBCL 后线研究需要把 CD30 表达、既往 ADC/双抗/CAR-T 暴露和骨髓毒性作为关键分层。
---	---	---

EPCORE NHL-1 三年更新：epcoritamab 治疗 R/R LBCL

Efficacy and safety of epcoritamab in relapsed or refractory large B-cell lymphoma: 3-year update from the EPCORE NHL-1 trial.

PMID 41634395

打开 PubMed 文献

双抗 / 长期随访临床研究 R/R LBCL MDAT 近7天滚动候选：未在历史日报出现；近期高相关参考/补充

P 复发/难治 LBCL 成人患者，含既往 CAR-T 暴露和多线耐药人群	I Epcoritamab CD3×CD20 双抗治疗	C 单臂长期随访；按 CR、MRD 和既往暴露分层解读	O ORR、CR、DOR、PFS、OS、MRD 阴性、CRS、感染
---	---	---	---

结论

EPCORE NHL-1 三年随访显示 epcoritamab 在 R/R LBCL 中 ORR 59%、CR 41%，CR 患者中 PFS 和 OS 持久，未见新的安全性信号。

主要内容

- 成人 R/R LBCL 接受 CD3×CD20 双抗 epcoritamab，治疗至进展或不可接受毒性。
- 中位随访 37.1 个月；39% 既往接受过 CAR-T，75% 对 ≥2 连续治疗线耐药。
- ORR 59%，CR 41%；中位 DOR 20.8 个月，中位 CR 持续 36.1 个月。
- CR 患者中位 PFS 37.3 个月；常见 AE 为 CRS、乏力和发热，无新安全性信号。

关键信息

- 未重复 PMID；双抗方向的长期随访价值高。
- MRD 阴性比例为 45%，为长期疾病控制提供额外观察维度。
- 感染 3 级为 24%，仍需在门诊化和长期用药中持续监测。

启示

已验证证据 PubMed 摘要确认三年随访、ORR/CR、DOR、PFS/OS、MRD 和感染分级数据。	论文作者观点 作者认为持久反应和 CR 患者长期生存提示 epcoritamab 可能带来长期无病生存。	我的推断 我的推断是，双抗日报应继续固定记录 CAR-T 暴露史、CR 深度、MRD 和感染分级，避免只汇总 ORR。
---	---	--

RLZT ± MTX 一线治疗 PCNSL：zanubrutinib 联合方案

Zanubrutinib, lenalidomide, rituximab, temozolomide ± methotrexate as first-line treatment for primary central nervous system lymphoma: A prospective, open-label, multicentre clinical trial.

PMID 41582824

打开 PubMed 文献

PCNSL / BTKi 联合前瞻临床试验

新诊断 PCNSL

MDAT 近7天滚动候选：未在历史日报出现；近期高相关参考/补充



新诊断 PCNSL 患者，尤其关注老年或强化化疗不适合人群



Zanubrutinib + lenalidomide + temozolomide + rituximab ± methotrexate



开放标签单臂/方案内分层；与传统 HD-MTX 基础方案背景比较



疗效、安全性、强化化疗不适合人群可行性

结论

前瞻、多中心、开放标签研究提示 zanubrutinib 联合 lenalidomide、temozolomide、rituximab ± methotrexate 作为 PCNSL 一线方案具有可行性，尤其面向不能接受强化化疗的老年患者。

主要内容

- 研究评估 zanubrutinib + lenalidomide + temozolomide + rituximab ± MTX 作为 PCNSL 一线治疗。
- 摘要描述该方案显示良好疗效和安全性。
- 特别强调老年或无法接受 intensive chemotherapy 的 PCNSL 患者。
- PubMed 摘要较短，详细 ORR/PFS/毒性需阅读全文补充。

关键信息

- 未重复 PMID；覆盖 CNSL/PCNSL 与 BTKi 前移方向。
- 与既往 PCNSL ibrutinib/R-MVP、Pen-RMA 等形成前移联合方案比较框架。
- 由于摘要信息有限，本页明确不虚构未见于摘要的数值。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认研究为前瞻、多中心临床试验，并确认 RLZT ± MTX 一线 PCNSL 方案方向。

论文作者观点

作者认为 RLZT ± MTX 显示良好疗效和安全性，尤其适用于无法接受强化化疗的老年患者。

我的推断

我的推断是，PCNSL 一线研究应把年龄、MTX 适合性、认知/神经毒性、CNS 药代和维持策略作为固定字段。

PCNSL 中 BET 高剂量化疗 + ASCT 的长期真实世界疗效与安全性

The long-term efficacy and safety of high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation in the treatment of primary central nervous system lymphoma: A real-world report from the Polish Lymphoma Research Group.

PMID 42139822

打开 PubMed 文献

PCNSL / ASCT 巩固真实世界

PCNSL

MDAT 近7天滚动候选：未在历史日报出现；近期高相关参考/补充

P 适合高剂量化疗和自体移植巩固的 PCNSL 患者

T R-MIV 诱导 + AT 周期 + HDC-BET-ASCT 巩固

C 真实世界观察队列；疫情期间 vs 非疫情期间亚组

O 移植相关死亡、4 年 PFS、4 年 OS、复发时间、二次缓解/二次 ASCT 可行性

结论

波兰淋巴瘤研究组真实世界队列显示，R-MIV 诱导后 BET 高剂量化疗 + ASCT 在适合移植 PCNSL 中可行，4 年 PFS 66%、OS 74%，但仍有移植相关死亡和早期复发。

主要内容

- 前瞻性观察研究，纳入 5 个血液肿瘤中心 60 例适合 HDC-BET-ASCT 的 PCNSL 患者。
- 诱导方案为 R-MIV，诱导末端加 1 个 AT 周期。
- 2 例因移植相关毒性死亡；中位随访 51 个月。
- 4 年 PFS 66%，4 年 OS 74%；25% 复发，其中多数发生在 12 个月内。

关键信息

- 未重复 PMID；CNSL 方向的巩固/真实世界证据。
- COVID-19 期间移植患者复发比例更高，但 4 年 OS/PFS 差异未达显著。
- 适合和 BTKi/PD-1 前移方案放在同一 PCNSL 治疗路径中比较。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认样本量、中心数、R-MIV/AT/BET-ASCT 路径、移植相关死亡、4 年 PFS/OS 和复发情况。

论文作者观点

作者认为 R-MIV 诱导后 HDC-BET-ASCT 策略在日常实践中可行且安全性可接受。

我的推断

我的推断是，PCNSL 方案设计应同时记录移植适合性、诱导深度、早期复发、感染时期背景和二次巩固可行性。

今天的信号不是单一药物热点，而是“疗效前移 + 治疗可及 + CNS/微环境分层 + 安全管理”同步推进

已验证证据 本轮官方 PubMed 候选 226 条；排除历史 PMID 后精选 5 篇未重复文献，覆盖 DLBCL BTKi、ADC、双抗长期随访，以及 PCNSL BTKi 一线和 ASCT 巩固。	论文作者观点 入页研究作者共同强调：R/R DLBCL 后线方案正在通过 ADC/双抗/BTKi 联合细化，PCNSL 则继续围绕 BTKi 前移、MTX 适合性和 ASCT 巩固路径优化。	我的推断 我的推断是，明天继续监测时应优先补充真正新入库且未覆盖的临床研究；滚动窗口命中但历史已覆盖的 PMID 只在总览中说明，不再重复成文献页。
下一次优先跟进 继续观察 frontMIND OS/ctDNA、PCNSL 双抗 CNS 穿透验证、双抗治疗中 PET 动态指标、CAR-T 可及性和桥接前 MTV 变化。	设计启示 DLBCL/CNSL 研究应同时记录疗效、到达治疗的路径、CNS/CSF 指标、影像负荷、分子/微环境分层和感染/神经毒性安全窗口。	边界提醒 本页仅作文献监测、证据摘要和方案设计启示整理，不提供医疗建议，也不生成治疗推荐。